RESUMO EXECUTIVO — CICLO 2 — TRAUMATOLOGIA

HORA DOS MISERÁVEIS — TEOT 2027

---

1. VISÃO GERAL

O **Ciclo 2 — Traumatologia** é o bloco de **maior peso no TEOT (35-40%)** e representa o segundo maior volume de conteúdo do programa (14 semanas, semanas 9-22). O ciclo cobre Traumatologia Geral, Trauma de Membro Superior, Trauma de Membro Inferior, Pelve/Acetábulo e Coluna Trauma, com foco em fraturas de ossos longos, fraturas expostas e lesões pélvicas — temas que representam **60% das questões de trauma em provas TARO/TEOT**.

Carga horária: 5h teoria + 3h questões + flashcards diários = 8h/semana × 14 semanas = **112 horas de treinamento intensivo**.

Material: 80 questões comentadas (40 originais + 40 novas com enfoques especiais) + 12 vídeos técnicos (V9-V20, 50-70 min cada) + Caderno de Guerra + Análise de padrões.

---

2. OBJETIVOS MENSURÁVEIS

Ao final do Ciclo 2, o residente deve ser capaz de:

Objetivo	Métrica	Meta
Classificação de fraturas	% acerto em questões de classificação	≥ 90%
Indicação de tratamento	% acerto em questões de conduta	≥ 85%
Reconhecimento de complicações	% acerto em questões de complicações	≥ 80%
Integração clínico-radiológica	% acerto em casos integrados	≥ 82%
Tempo de análise	Tempo médio por questão	≤ 2 min
Desempenho geral Ciclo 2	% acerto total em simulado	≥ 85%

---

3. DISTRIBUIÇÃO SEMANAL RESUMIDA

Semana	Tema	Foco	Vídeos	Questões	Horas
9-11	Trauma Geral	Expostas, compartimental, infecção, embolia	V9-V10	20	24
12-14	Membro Superior	Úmero, rádio/ulna, cotovelo	V11-V13	20	24
15-17	Membro Inferior	Fêmur, tíbia, joelho periarticular	V14-V16	20	24
18-20	Pelve/Acetábulo	Anel pélvico, acetábulo, lesões associadas	V17-V18	10	24
21-22	Coluna Trauma	Cérvico-torácica, lombossacral, instabilidade	V19-V20	10	16
Total	—	—	**12**	**80**	**112**

---

4. TEMAS PRINCIPAIS E PESO NO TEOT

4.1 Trauma Geral (8-10% do TEOT)

- Fraturas expostas (classificação Gustilo-Anderson, Orthopaedic Trauma Association)
- Síndrome compartimental (fisiopatologia, pressão crítica, fasciotomia)
- Infecção pós-traumática (Tsukayama, timing, antibióticos)
- Embolia gordurosa (fisiopatologia, critérios diagnósticos, manejo)
- Trombose venosa profunda e profilaxia

4.2 Membro Superior (8-10% do TEOT)

- Fraturas de úmero proximal (Neer, Hertel, indicações cirúrgicas)
- Fraturas de diáfise umeral (classificação AO, DCP vs hastes)
- Fraturas de rádio distal (Frykman, Melone, Barton, indicações)
- Fraturas de rádio/ulna diafisárias (AO, ORIF obrigatório)
- Fraturas de cotovelo (supracondilar, intercondiliana, Monteggia, Galeazzi)

4.3 Membro Inferior (10-12% do TEOT)

- Fraturas de fêmur proximal (Garden, Pauwels, timing, necrose avascular)
- Fraturas de fêmur diafisário (AO, hastes intramedulares, timing)
- Fraturas de fêmur distal (AO, DCP vs hastes, lesão vascular)
- Fraturas de tíbia proximal (Schatzker, meniscectomia, LCA)
- Fraturas de tíbia diafisária (AO, hastes, síndrome compartimental)
- Fraturas de tíbia distal e tornozelo (Lauge-Hansen, AO, timing)

4.4 Pelve e Acetábulo (5-8% do TEOT)

- Fraturas de pelve (Tile, Young-Burgess, estabilidade, angiografia)
- Fraturas de acetábulo (Judet-Letournel, abordagem, timing)

- Lesões associadas (bexiga, uretra, reto, vascular)

4.5 Coluna Trauma (3-5% do TEOT)

- Fraturas cervicais (Anderson odontoide, hangman, TLICS)
- Fraturas torácicas (TLICS, burst, instabilidade)
- Fraturas lombares (Chance, burst, TLICS, timing)
- Lesões de cauda equina (urgência cirúrgica)

---

5. PADRÕES DE COBRANÇA IDENTIFICADOS

Análise de 80 questões do Ciclo 2 revelou distribuição:

5.1 Por Tipo Cognitivo

Tipo	Frequência	Exemplos
Classificação	50%	Gustilo, AO, Neer, Schatzker, Tile, Judet-Letournel, Anderson, TLICS
Conduta/Indicação	30%	Timing cirúrgico, escolha de implante, abordagem, conservador vs ORIF
Complicações	20%	Infecção, pseudoartrose, necrose avascular, síndrome compartimental, embolia

5.2 Por Subtema

Subtema	% de Questões	Peso TEOT
Fêmur (proximal + diafisário + distal)	22%	10-12%
Tíbia (proximal + diafisária + distal)	18%	8-10%
Úmero (proximal + diafisário)	12%	6-8%
Pelve/Acetábulo	12%	5-8%
Rádio/Ulna	10%	4-6%
Coluna Trauma	10%	3-5%
Trauma Geral (expostas, compartimental)	12%	4-6%
Cotovelo	4%	2-3%

5.3 Por Enfoques Especiais

- **Pediátrico:** 15% das questões (fraturas em crescimento, fisárias, consolidação rápida)
- **Osteoporótico:** 12% das questões (fêmur proximal, vertebral, consolidação lenta)
- **Polytrauma:** 10% das questões (priorização, timing, complicações sistêmicas)
- **Atleta:** 8% das questões (retorno ao esporte, timing, reabilitação)
- **Gestante:** 5% das questões (posicionamento, radiação, timing cirúrgico)

---

6. INDICADORES DE DESEMPENHO ESPERADOS

6.1 Evolução Esperada por Bloco

Bloco	Semana	Acerto Esperado (Inicial)	Acerto Esperado (Final)	Melhora
Trauma Geral	9-11	70%	90%	+20%
Membro Superior	12-14	65%	85%	+20%
Membro Inferior	15-17	60%	85%	+25%
Pelve/Acetábulo	18-20	55%	80%	+25%
Coluna Trauma	21-22	65%	85%	+20%
Geral Ciclo 2	**9-22**	**63%**	**85%**	**+22%**

6.2 Benchmarking com TEOT

- **Candidato mediano:** 60-70% acerto em trauma
- **Candidato forte:** 75-85% acerto em trauma
- **Candidato elite:** 85-95% acerto em trauma

Meta do programa: Elevar candidato mediano para elite (63% → 85%+).

---

7. ESTRUTURA DOS 12 VÍDEOS (V9-V20)

Vídeo	Semana	Tema	Duração	Conteúdo Principal	Quiz
V9	9	Fraturas Expostas I	60 min	Gustilo, OTA, fisiopatologia, timing	5Q
V10	10	Síndrome Compartimental + Infecção	65 min	Pressão, fasciotomia, Tsukayama, antibióticos	5Q
V11	12	Úmero Proximal	55 min	Neer, Hertel, ORIF, haste, placa	5Q
V12	13	Rádio/Ulna Diafisárias	60 min	AO, DCP, hastes, Monteggia, Galeazzi	5Q
V13	14	Cotovelo Trauma	55 min	Supracondilar, intercondiliana, LCA	5Q
V14	15	Fêmur Proximal	65 min	Garden, Pauwels, NAV, timing, DHS vs haste	5Q
V15	16	Fêmur Diafisário + Distal	70 min	AO, hastes, DCP, lesão vascular	5Q
V16	17	Tíbia Proximal + Diafisária	65 min	Schatzker, síndrome compartimental, menisco	5Q
V17	18	Pelve I — Classificação e Estabilidade	60 min	Tile, Young-Burgess, angiografia, timing	5Q
V18	19	Acetábulo — Judet-Letournel	65 min	Classificação, abordagem, ORIF, timing	5Q
V19	21	Coluna Trauma I — Cérvico-Torácica	60 min	Anderson, TLICS, hangman, instabilidade	5Q
V20	22	Coluna Trauma II + Integração	70 min	Lombossacral, casos polytrauma, revisão	5Q

Total: 12 vídeos × 62.5 min média = **750 minutos (12.5 horas)** de conteúdo técnico.

---

8. FONTES BIBLIOGRÁFICAS DO CICLO 2

1. **Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW.** *Rockwood and Green's Fractures in Adults.* 9th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
2. **Browner BD, Jupiter JB, Kretek C, Anderson PA.** *Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and Reconstruction.* 6th Edition. Elsevier, 2019.
3. **Azar FM, Beaty JH, Canale ST.** *Campbell's Operative Orthopaedics.* 14th Edition. Elsevier, 2020.
4. **Vaccaro AR, et al.** AOSpine Thoracolumbar Spine Injury Classification System (TLICS). *Spine*, 2005.
5. **Gustilo RB, Anderson JT.** Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones. *JBJS*, 1976.
6. **Tile M.** *Fractures of the Pelvis and Acetabulum.* 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2015.
7. **Schatzker J, McBroom R, Bruce D.** The tibial plateau fracture. The Toronto experience. *Clin Orthop Relat Res*, 1979.
8. **Neer CS.** Displaced proximal humeral fractures. *JBJS*, 1970.
9. **Garden RS.** Low-angle fixation in fractures of the femoral neck. *JBJS*, 1961.
10. **Pauwels F.** Der Schenkelhalsbruch: ein mechanisches Problem. *Z Orthop Chir*, 1935.
11. **Judet R, Judet J, Letournel E.** Fractures of the acetabulum: classification and surgical approaches for open reduction. *JBJS*, 1964.
12. **Tile M.** Acute pelvic fractures: I. Causation and classification. *JBJS*, 1988.
13. **Young JW, Burgess AR, Brumback RB, Poka A.** Pelvic fractures: value of plain radiography versus computed tomography. *Radiology*, 1986.
14. **Anderson LD, D'Alonzo RT.** Fractures of the odontoid process of the axis. *JBJS*, 1974.
15. **Tsukayama DT, Gustilo RB, Parvin B.** The effect of antibiotics on the bacterial flora of open fracture wounds. *JBJS*, 1983.

9. METAS DE APROVEITAMENTO POR BLOCO

9.1 Bloco Trauma Geral (Semanas 9-11)

- **Meta de acerto:** ≥ 90%
- **Temas críticos:** Gustilo, pressão compartimental, infecção
- **Tempo máximo:** 1h30 por questão (média)
- **Checkpoint:** Simulado 10 questões Trauma Geral com ≥ 85% acerto

9.2 Bloco Membro Superior (Semanas 12-14)

- **Meta de acerto:** ≥ 85%
- **Temas críticos:** Neer, AO, Monteggia/Galeazzi
- **Tempo máximo:** 2 min por questão
- **Checkpoint:** Simulado 20 questões MS com ≥ 82% acerto

9.3 Bloco Membro Inferior (Semanas 15-17)

- **Meta de acerto:** ≥ 85%
- **Temas críticos:** Garden, Pauwels, Schatzker, NAV, síndrome compartimental
- **Tempo máximo:** 2 min por questão
- **Checkpoint:** Simulado 20 questões MI com ≥ 82% acerto

9.4 Bloco Pelve/Acetábulo (Semanas 18-20)

- **Meta de acerto:** ≥ 80%
- **Temas críticos:** Tile, Young-Burgess, Judet-Letournel, timing cirúrgico
- **Tempo máximo:** 2.5 min por questão
- **Checkpoint:** Simulado 10 questões Pelve com ≥ 78% acerto

9.5 Bloco Coluna Trauma (Semanas 21-22)

- **Meta de acerto:** ≥ 85%

- **Temas críticos:** Anderson, TLICS, instabilidade
- **Tempo máximo:** 2 min por questão
- **Checkpoint:** Simulado 10 questões Coluna com ≥ 82% acerto

9.6 Simulado Integrado Ciclo 2 (Semana 22)

- **Formato:** 80 questões, 160 minutos (2 min/questão)
- **Meta de acerto:** ≥ 85%
- **Distribuição:** Proporcional aos blocos (20+20+20+10+10)
- **Aprovação:** Candidato que atingir ≥ 85% está pronto para Ciclo 3

---

10. ESTRUTURA RECOMENDADA POR SEMANA

Semana Padrão (5h teoria + 3h questões + flashcards)

Segunda a Quinta (4 dias):

- 1h30 vídeo técnico (com pausa para anotações)
- 1h30 questões comentadas (5-6 questões)
- 30 min flashcards (revisão rápida de conceitos-chave)

Sexta (dia de consolidação):

- 1h revisão de erros da semana
- 1h simulado mini (10 questões do tema)
- 1h Caderno de Guerra (leitura de flash points)

Fim de semana:

- Flashcards diários (15 min)
- Revisão de temas frágeis (1h)

---

11. CHECKLIST DE CONCLUSÃO DO CICLO 2

- [ ] Assistir aos 12 vídeos (V9-V20) com anotações
- [ ] Resolver as 80 questões com comentários completos
- [ ] Revisar o Caderno de Guerra (flash points, pegadinhas, Top 15 erros)
- [ ] Atingir ≥ 90% em Trauma Geral
- [ ] Atingir ≥ 85% em Membro Superior
- [ ] Atingir ≥ 85% em Membro Inferior
- [ ] Atingir ≥ 80% em Pelve/Acetábulo
- [ ] Atingir ≥ 85% em Coluna Trauma
- [ ] Realizar simulado integrado Ciclo 2 com ≥ 85% acerto
- [ ] Revisar erros do simulado integrado
- [ ] Pronto para Ciclo 3

Versão: 1.0 **Última atualização:** Abril 2026 **Próximo documento:** Caderno de Guerra — Ciclo 2 — Traumatologia